

Fecha Última Actualización: 17-10-2022 12:51:10

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Víctor Eduardo Mejías Cáceres
Edad : 36a 1m 29d
Dirección : Los Zorzales 057 0

Rut : 16.441.086-2
Fecha Nacto: 18/08/1986
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1825417
Sexo : Masculino
Teléfono : 958908627

N° Epicrisis
326963

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 11/10/2022 05:19
Fecha Egreso : 17/10/2022 12:10

Días Estadía : 6

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

TEC grave

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS UCI 12/10/2022

Antecedentes

Médicos: Asma. Consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Medicamentos: Salbutamol SOS.

Quirúrgicos: Niega.

Alergias: Niega.

Hábitos: Consumo y de tabaco y OH (+). Consumo de cocaína, marihuana y pasta base.

Historia clínica

Paciente con antecedentes referidos, acude al SAPU San Gerónimo por sus propios medios señalando que fue agredido por terceros, durante la consulta presenta compromiso de conciencia, convulsión tónico clónica y caída de Glasgow hasta 6/15; en ese contexto se decide intubación orotraqueal para lo que se administra Lorazepam, intentan intubación que resulta frustra, es derivado de forma urgente al servicio de emergencia de esta institución en donde ingresó el 11/10/2022 aproximadamente a las 03:39 H en Glasgow 3/15, requiere intubación urgente que se realiza al primer intento; se mantiene con collar cervical, múltiples heridas en cuero cabelludo, pupilas isocóricas, normorreactivas, herida cortante en mano derecha.

Al laboratorio destaca lactato 260, CK total 166, creatinina 0.95, LDH 323, PCR 53.4, INR 2.33, pH 6.6, bicarbonato 3.5. Se reanima con volumen, lactato de control 7.4, pH 7.33, bicarbonato 18.

Se realiza TC de cerebro que revela hematoma intraparenquimatoso parietal izquierdo, TC de tórax, abdomen y pelvis que informa sin patología aguda y TC de extremidades.

Se realizó TC de cerebro de control 7 hr después de la TC inicial. Evaluada por neurocirugía: contusión parietal conocida con leve crecimiento, sin efecto de masa, sin nuevas lesiones, refiere iniciar destete. Sin indicación neuroquirúrgica al momento.

Evaluado por traumatología, herida cortante en mano derecha que es suturada. Además, evalúa TC de columna cervical no evidencia lesión ósea aguda y TC TAP no se evidencia lesiones a nivel de EESS, sin lesión en pelvis ni cadera.

En ese contexto ingresa a UCI.

Al examen físico ingresa sedoanalgesiado con Propofol, en RASS -2, pupilas isocóricas, mióticas, hiporreactivas, intubado, se conecta a ventilación mecánica protectora, sibilancias bilaterales, crepitantes en ambas bases pulmonares, secreciones

Fecha Epicrisis : 17/10/2022 12:51

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 17-10-2022 12:51:10

Página 2 de 3

respiratorias escasas pero mucopurulentas, R1 y R2 normofonéticos, llenado capilar 2 segundos, abdomen blando, depresible, RHA presentes, sutura cubierta con apósito seco y limpio en mano derecha, extremidades inferiores simétricas. Bajo normas de asepsia y antisepsia, guía ecográfica y técnica Seldinger se coloca vía venosa central yugular derecha, al primer pinchazo sin intercurencias, se realiza Ecoscopia con paso de burbujas visible en lado derecho. Control radiográfico sin complicaciones, CVC normoinserito.

Diagnóstico de ingreso a UCI

- TEC grave

Hematoma intraparenquimatoso parietal izquierdo

TC de control con crecimiento leve, sin desviación de línea media.

Fractura parietal izquierda, conminuta

Crisis convulsiva

- Hiperlactatemia / Acidosis metabólica severa con AG aumentado (29)

- Herida cortante palma derecha

Evolución en UCI

- Hemodinámico: Mantuvo hemodinamia autosostenida con hiperlactatemia que respondió de forma satisfactoria y precoz a volemicación. Bien perfundido clínicamente, sin requerimientos de DVA. Al alta sin conflicto.

- Respiratorio: Sin evidencia de contusión pulmonar, sin alteración de intercambio gaseoso. Se extuba el 14/10 sin incidentes. Al momento del alta sin requerimientos de O2 suplementario, sin conflicto ventilatorio.

- Metabólico: A su ingreso con acidosis metabólica severa con AG aumentado (29), probablemente en contexto de hiperlactatemia e intoxicación por drogas de abuso (consumo reciente de cocaína). Con buena respuesta a volemicación inicial. Conflicto resuelto al alta.

- Neurológico: TEC grave con hematoma intraparenquimatoso izquierdo y fractura ipsilateral con hundimiento de cráneo. En seguimiento por neurocirugía se le realizaron TAC de control el 14 y 17 de octubre. Ambos satisfactorios con estabilidad de hematoma. Se inicia FAE con levetiracetam en contexto de convulsión al ingreso con 500 mg c/12 hr. En visita de neurocirugía el 17/10 plantean alta con control precoz con Dr. Ramírez el 21/10 en SU.

- Infectológico: Se sospechó neumonía aspirativa por lo que completó 5 días de Ampicilina/Sulbactam. Con adecuada evolución, afebril y parámetros inflamatorios a la baja. Al alta se indica Amoxicilina con Ac. Clavulánico a completar 2 días más (7 días total total).

- Renal: Sin conflicto.

Diagnóstico de egreso de UCI

- TEC grave

Hematoma intraparenquimatoso parietal izquierdo estable

Fractura parietal izquierda

Crisis convulsiva yugulada con FAE

- Hiperlactatemia / Acidosis metabólica severa con AG aumentado (29) resultas

- Herida cortante palma derecha

Diagnóstico de Egreso

TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Buenas condiciones generales. Sin conflicto hemodinámico ni ventilatorio. Afebril. De alta por neurocirugía, con control en SU el viernes 21/10.

Movilizándose con marcha asistida.

Dado de alta de fonoaudiología, sin restricciones de régimen.

Plan Post Alta

Fecha Epicrisis : 17/10/2022 12:51

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 17-10-2022 12:51:10

Página 3 de 3

Reposo relativo.
Régimen común.

Medicamentos:

- Amoxilina con Ácido Clavulánico 500/125 mg. 1 comprimido cada 8 horas hasta el 19/10 (incluido).
- Levetiracetam 500 mg cada 12 horas hasta control con neurología.
- Clonazepam 1 mg en la noche vía oral en caso de insomnio.

Controles:

- Viernes 21/10 acudir a servicio de urgencia a las 09:00 con esta epicrisis. Dr. Ramírez de neurocirugía lo citó a control en la misma unidad.
- Solicitar hora con neurología para seguimiento de uso de Levetiracetam y evaluar suspensión.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Común

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Tomás Lahera Frohmann
Médico Tratante (Staff)